

Método CrowdPharma — Adopción de Farmacia / Socio Fundador

Prefacio (léeme primero)

Para quién: tú, cuando quieres que una farmacia o partner **pague o se comprometa** por usar la plataforma (ingreso B2B).

No es para: pedir capital a un inversor (eso es SAFE) ni solo “probar la app gratis” (eso es Alfa).

En una frase de calle: “Reserva un cupo de farmacia → te damos onboarding y capacidad; pagas por servicio, no por acciones.”

Antes de seguir: [GLOSARIO](#) · [Comparativa](#) · [Qué hacer ahora](#)

Estado: [PROPUESTA OPERATIVA – NO AUTORIZA CONTACTO]

Versión: 1.1 — 27 agosto 2026 (controles críticos + criterios de parada + KPI comerciales; destilado DOCX plan-operativo)

Para qué sirve: plan detallado y fácil de ejecutar para conseguir **compromiso económico B2B** (farmacias y socios) inspirado en crowdfarming, **sin** mezclarlo con inversión.

Canon intacto: ask SAFE **USD 237.412** (no recaudado) · cap **USD 1.582.747** · equity ref. ~15% · pricing **45/60/70 + 8/7/5% GMV**.

Evidencia: [evidencia/EXT_CROWDFARMING.md](#)

No es dictamen legal/contable. Abogado y contador cierran contratos, refunds y reconocimiento.

Alfa/Beta: detalle en [PLAN_ALFA_BETA.md](#) — este MD no fusiona el experimento.

1. En una frase

En CrowdFarming “adopta un árbol → recibes fruta”.

En Zonix **CrowdPharma**: “adopta un **cupo de farmacia/socio fundador** → recibes **plataforma, onboarding y capacidad garantizada**”.

El dinero que entra es **prepago / piloto / contrato** (ingreso B2B), **no** capital SAFE.

(diagrama omitido en PDF)

2. Qué es / qué no es

Sí es	No es
Customer-funded B2B (demanda anticipada)	Crowdfunding de equity / valores
Coordinación oferta-demanda del piloto	Método oficial de CrowdFarming.com
Camino comercial hacia S1 (y S2 solo tras gates)	Sustituto del ask SAFE 237.412
Oferta lucrativa por valor operativo	Promesa de TIR, dividendos o “recuperas lo pagado”
Cupos limitados por capacidad de soporte	FOMO / escasez falsa de marketing

Quién aporta dinero	Instrumento	Recibe	No recibe
Farmacia	Piloto / contrato / (futuro) prepago	Servicio, cupo, white-glove, métricas	Equity, profit share
Socio delivery	Fee activación / LOI+SLA	Flujo de órdenes, prueba, prioridad piloto	Equity por volumen
Inversor	SAFE (carril A)	Derechos del SAFE	Beneficios de cliente “por invertir”

Misma persona en dos roles = **dos instrumentos** ([02_CARRILES.md](#)).

3. Reglas no negociables (CrowdPharma)

Además de [01_REGLAS_Y_CANON.md](#) :

1. **Copy de consumo, no de inversión.** Prohibido: “invierte”, “socio capitalista”, “retorno”, “rentabilidad garantizada”, “recuperas tu cuota”.
2. **Promesa entregable.** No cobrar sin definir qué se entrega, cuándo y qué pasa si falla.
3. **Reserva de cumplimiento.** No gastar el 100% del dinero anticipado; separar pasivo de servicio.
4. **Máximo 10 fundadoras** en cohorte S1; el límite es capacidad, no hype.
5. **Sin crowdfarming de pacientes** ni waitlist masiva en la app.
6. **Sin contacto** hasta CAP-P09 + OK explícito.
7. **S2 / paquete Anual** permanece no aprobado hasta gates + CAP-P03 / CAP-P04 .
8. **No cambia** 45/60/70 ni el SAFE sin decisión founder versionada.

3.1 Tres controles críticos (blindaje)

Destilado del plan operativo B2B 27 ago. Sin estos, no hay cobro limpio.

#	Riesgo	Control
1	Roles mezclados (farmacia/partner también “quiere invertir”)	Misma persona = dos instrumentos y dos conversaciones. Cupo → este método. Capital → SAFE (PLAN_SAFE_GABRIEL). Nunca descuento de cuota “por aportar capital”.
2	Cobro sin promesa	Cero depósito/fee/prepago sin definir entrega, plazos y path de refund (CAP-P05). Si falta → solo Alfa (prueba sin cobro).
3	Ledger mezclado con SAFE	Caja B2B (Semilla/Fundadora) separada del ask SAFE. Nunca presentar N×P ni anticipos como “capital levantado” / “ya recaudamos 237k”.

4. Qué necesitamos antes de vender una adopción

Requisito	Por qué	Estado típico
Demo 3–5 min usable	Sin entrega no hay CrowdPharma	Gate producto
≥5 mom-test B2B documentados	Dolor real, no pitch inventado	Gate discovery

Requisito	Por qué	Estado típico
Capacidad onboarding ≤10	Cupo creíble	Operación
Formulario inbound fuera de la app	Señal cualificada (Kleo)	Proceso
CAP-P01 cerrado si se menciona waiver	No ambigüedad %GMV	Contrato
Plantilla LOI/contrato [PENDIENTE abogado]	Obligación clara	Legal
Política refund / cancelación	Confianza + IFRS 15	Legal/contador
Ledger B2B separado del SAFE	Tres universos de dinero	Finanzas
Script de visita sin palabras de “inversión”	AppSec/copy	Founder

Si falta algo de la tabla → **NO-GO** de cobro anticipado; solo Alfa (prueba sin waiver) según [PLAN_ALFA_BETA.md](#) .

5. La oferta (qué se vende) — atractiva y lucrativa en valor operativo

5.1 Paquetes

Paquete	Quién	Qué paga / compromete	Qué recibe	Estado
Semilla	Farmacia en prueba	Depósito parcial o mes 1 con descuento operativo acotado; o piloto 30–60 días con fee de activación bajo	Acceso app, onboarding básico, 1 visita/capacitación, canal soporte	Elegible tras demo + mom-test
Fundadora	Farmacia cohorte	Contrato marco + waiver canónico (cuota fija USD 0 meses 1–2, máx. 10 ; %GMV = CAP-P01)	White-glove, prioridad de agenda, co-diseño, reporte del piloto, case study con consentimiento, acceso Day-D del programa	Tras uso real (Alfa→Beta)
Anual anticipado	Farmacia post-validación	Prepago anual asignado a prestaciones (onboarding, panel, soporte)	Misma lógica S2: servicio por adelantado + reserva	[NO APROBADO] hasta gates S2
Socio Ruta	delivery_company	Fee de activación / depósito de prueba o LOI+SLA	Integración al flujo, prueba operativa, prioridad de volumen del piloto, dashboard	Paralelo a farmacias; sin exclusividad

Precios de referencia (canon): Basic **45 + 8%**, Pro **60 + 7%**, Enterprise **70 + 5%**. CrowdPharma no inventa un menú paralelo.

5.2 Por qué es “lucrativo” para quien entra (sin rentismo)

Se vende **retorno operativo**, no financiero. Ejemplos de argumentos (siempre con supuestos y “no garantizado”):

Dolor típico farmacia VE	Qué gana con el cupo	Cómo se mide
Pedidos desordenados / WhatsApp caótico	Flujo digital + trazabilidad	Órdenes completadas / semana
Rx y validación lentas	Flujo Rx en plataforma	Tiempo a despacho
Poca visibilidad de demanda	Catálogo online + pacientes del piloto	GMV / primeras órdenes
Capacitación cara	White-glove fundadora incluido en cohorte	Horas de soporte vs errores
Riesgo de pagar SaaS sin probar	Waiver 0x2 (Fundadora) o Semilla acotada	Conversión a pago post-mes 2

Frase permitida: “Entras para **usar y medir**; si no aporta, sales según contrato.”

Frase prohibida: “Entras para **ganar dinero** con Zonix / recuperar la cuota.”

5.3 Beneficios permitidos vs prohibidos

Permitidos: prioridad de agenda; capacitación; canal founder; co-diseño; métricas del piloto; case study con OK; cupo por capacidad.

Prohibidos: equity; dividendos; profit share; TIR; exclusividad territorial indefinida; analytics inexistente; posicionamiento preferente no construido; FOMO (“quedan 3”); analogías Flyfish / “inversión en cafetería”.

6. Cómo convencer (persuasión B2B)

6.1 Guion de 6 pasos (visita o llamada)

- Problema:** “¿Qué se rompe hoy al vender con delivery / Rx / stock?” (mom-test; callar y anotar).
- Prueba:** demo 3–5 min con un pedido controlado.
- Cupo:** “Solo podemos incorporar bien hasta 10 en esta cohorte; el límite es soporte, no marketing.”
- Oferta:** Semilla o Fundadora según si ya usó la app.
- Transparencia de precio:** mostrar 45/60/70 + %GMV; si Fundadora, explicar waiver **sin** ambigüedad (CAP–P01).
- Cierre blando:** LOI o fecha de onboarding; nunca “invierte hoy”.

6.2 Objeciones frecuentes

Objeción	Respuesta
“¿Esto es inversión?”	“No. Es contrato de servicio de plataforma. Si quieres capital, es otro instrumento (SAFE) y otra conversación.”
“¿Recupero lo que pago?”	“No. Pagas por uso y soporte. Mides si te conviene con órdenes y tiempo.”
“¿Por qué solo 10?”	“Porque el onboarding white-glove no escala en el piloto; si abrimos más, baja la calidad.”
“¿Exclusividad en mi zona?”	“No en piloto. Puedes ser case study; no bloqueamos el mapa.”
“¿Y si no funciona?”	“Contrato con salida/refund según plantilla legal; no pedimos fe ciega.”

Objeción	Respuesta
"Pásame un % de las ganancias"	"No. Cliente ≠ accionista. Canon cerrado."

6.3 Embudo CrowdPharma (carril B)

- 1. Prospecto Valencia (censo / referidos).
- 2. Mom-test.
- 3. Demo.
- 4. Reacción a pricing documentada.
- 5. **Adopción Semilla** o compromiso LOI.
- 6. Uso real (catálogo + pedido).
- 7. **Adopción Fundadora** (Beta/S1) si gates OK.
- 8. Factura pagada / retención.
- 9. (Futuro) evaluar Anual solo post-cobro.

Señal mínima para contar un lead: decisor + sede Valencia + catálogo + farmacéutico colegiado disponible.

6.4 Script WhatsApp (borrador, tono pharma)

Hola [Nombre], soy [Founder] de **Zonix Pharma**. Estamos armando una cohorte chica de farmacias en Valencia para probar pedidos + Rx en app (máx. 10, por capacidad de soporte).
No es inversión ni sociedad: es **prueba de plataforma** con acompañamiento.
¿Te sirve una demo de 10 minutos esta semana?

7. Pasos operativos (checklist de ejecución)

Estilo CrowdFarming § mecánica, adaptado:

#	Paso	Dueño	Evidencia
1	Definir "unidad productiva" = 1 farmacia o 1 partner delivery	Founder	Ficha ICP
2	Crear ficha pública interna (problema, qué incluye, precio, límites, refund)	Founder + UX writer	1 página
3	Abrir CTA inbound "evaluación / adopción de cupo" (fuera de Flutter)	Ops	Formulario
4	Cualificar leads (decisor, sede, catálogo, farmacéutico)	Sales/founder	CRM §6 VOLCADO
5	Asignar cupo (1...10) y fecha de onboarding	Ops	Ledger cupos
6	Firmar LOI/contrato según paquete	Legal/founder	PDF firmado
7	Cobrar depósito/fee solo si hay promesa entregable	Finanzas	Recibo + pasivo
8	Onboarding: catálogo, usuarios, Rx smoke	CS/tech	Checklist
9	Primera orden real	Farmacia + delivery	E4
10	Reporte semanal a la farmacia	CS	PDF/minuta

#	Paso	Dueño	Evidencia
11	Conversión a pago post-waiver / renovación	Finanzas	Factura
12	Decidir ampliar o parar (gates)	Founder	GO/NO-GO

Código app: no hace falta feature “crowdfarming” ni waitlist. `SubscriberController` no se reutiliza para farmacias.

8. Economía para Zonix (sin sustituir el SAFE)

CrowdPharma mejora **caja operativa y evidencia de mercado**; el raise sigue siendo SAFE.

```
N = farmacias/socios con adopción pagada o contractual en ventana
P = ticket del paquete (fee, depósito neto, o cuota reconocible)
cash_collected      = suma cobrada
contract_liability   = parte aún no prestada
reserve_required     = refunds + cumplimiento + contingencia
cash_usable          = cash_collected - reserve_required - impuestos aplicables
```

Reglas:

- Umbral mínimo antes de gastar en marketing outbound: p. ej. **≥3 adopciones Semilla con uso o ≥1 Fundadora con E4**; ajustar con founder (no inventar P10/P50/P90).
- Interés verbal ≠cash.
- Nunca presentar N×P como “capital levantado”.
- Evidencia E3–E5 alimenta carril A ([02_CARRILES.md](#) escalera).

Detalle S0/S1/S2: [03_ESCENARIOS_S0_S1_S2.md](#) .

8.1 KPI comerciales semanales (no auditoría IIA)

Metas de **pipeline B2B**, no de compliance corporativo. Dashboard: [05_CALENDARIO_Y_DASHBOARD.md](#) . Números de meta = `ASSUMPTION` hasta que haya cohorte `FACT` .

Indicador	Qué cuenta	Señal de salud
Leads cualificados	Decisor + Valencia + catálogo + farmacéutico disponible	Embudo \$6.3 vivo
Demos hechas	Demo 3–5 min con reacción a pricing documentada	Sin demo → no Semilla
Adopciones Semilla	Depósito/fee/piloto con promesa entregable	≥1 con uso antes de outbound fuerte (<code>ASSUMPTION</code>)
Fundadoras (Beta)	Contrato + waiver + uso real	Solo post-Alfa; máx. 10
E4 (primera orden real)	Pedido medible en plataforma	Evidencia para carril A
Cash vs pasivo vs reserva	Cobrado – servicio pendiente – reserva	<code>cash_usable</code> > 0 antes de gastar anticipos

No uses KPIs de “auditorías ejecutadas / ROI de control / madurez COBIT” en este método: son otra capa.

9. Gates de decisión (GO / NO-GO)

Gate	Pregunta	Si falla
G0 Problema	¿Hay ≥1 dolor urgente verificado?	Solo discovery
G1 ICP	¿Farmacia independiente/mediana Valencia?	No contar lead
G2 Demanda	¿Señal cualificada (formulario/demo)?	No cobrar
G3 Dinero	¿Depósito/piloto/contrato firmado?	No construir extras
G4 Build	¿Umbral económico/uso definido superado?	Congelar scope
G5 MVP valor	¿Catálogo + pedido medible?	Corregir onboarding
G6 Retención	¿Sigue usando tras la novedad?	No ampliar cupos
G7 Scale	¿Unit economics y soporte OK?	No ir a ~28 sin reloj post-wire

Gates S2 (Anual) — heredar [03_ESCENARIOS_S0_S1_S2.md](#) : mom-test, WTP, ciclo post-waiver cobrado, margen, refund, contador, abogado, reproyección founder.

9.1 Criterios de parada (detener onboarding)

Si ocurre cualquiera → **parar** incorporación / cobro hasta corregir (no seguir “para no perder el cupo”):

1. El formulario inbound atrae **pacientes / waitlist** en lugar de **decisores B2B** farmacia o partner.
2. Los **mismos fallos críticos** (catálogo, Rx, pedidos) se repiten en **>2 farmacias** sin fix de fondo.
3. No hay **CAP-P09 + OK founder** para outreach o scripts.
4. El **%GMV / waiver** sigue ambiguo (CAP-P01 abierto) y se pretende firmar Fundadora.

Detalle del experimento Alfa/Beta (parada de producto): [PLAN_ALFA_BETA.md](#) .

10. Riesgos

Riesgo	Mitigación
Copy suena a valor/security (Howey / SUNAVAL)	Plantilla revisada por abogado; vocabulario de servicio
Prepago = pasivo no provisionado	Reserva + IFRS 15 (CAP-P04)
Prometer analytics/exclusividad inexistente	Solo beneficios de \$5.3 permitidos
Mezclar farmacia-inversora	Dos contratos; sin descuento por capital
Gastar anticipos en burn	cash_usable y umbral G3/G4
Pacientes como “adoptantes”	Prohibido en piloto
Contacto sin OK	CAP-P09

11. Calendario 90 días (condicionado a CAP-P09)

Ventana	Acciones CrowdPharma	No hacer
Días 1-14	Cerrar demo, mom-test ≥ 5 , ficha oferta Semilla, formulario	Outreach masivo
Días 15-45	Hasta 10 pruebas Alfa; 0-3 Semilla si hay entrega	Vender Anual/S2
Días 46-75	Convertir uso real $\rightarrow$ Fundadora (Beta) solo con CAP-P01	FOMO / exclusividad
Días 76-90	Medir E4/E5, soporte, conversión a pago; armar evidencia para SAFE	Decir "ya recaudamos"

Relojes pre-wire / post-wire: [05_CALENDARIO_Y_DASHBOARD.md](#) .

12. Checklist del founder (imprimible)

Antes (cierre operativo — priorizar)

- ☐ CAP-P09 autorizado (o explícitamente solo materiales, sin contacto).
- ☐ CAP-P05 : plantillas LOI/contrato de adhesión + **política de refund** formalizadas (o camino legal claro). **Sin esto $\rightarrow$ no abrir CTA Semilla** aunque haya demos.
- ☐ Demo OK + ≥ 5 mom-test.
- ☐ Ficha Semilla/Fundadora sin palabras de inversión (§3.1).
- ☐ Cupos 1-10 en hoja.
- ☐ Controles §3.1 verificados (roles / promesa / ledger).

Cada semana (KPI §8.1)

- ☐ Leads cualificados / demos / Semilla / Fundadora / E4.
- ☐ Incidencias de onboarding (¿activan parada §9.1?).
- ☐ Caja cobrada vs pasivo vs reserva.
- ☐ ¿Algún copy se desvió a "retorno"? Corregir.

Para el raise (carril A)

- ☐ Usar solo evidencia E3+ con disclosure.
- ☐ SAFE separado; no vender SAFE en la misma hoja que Fundadora.

13. Relación con Alfa / Beta / S0-S2

Pieza	Relación con CrowdPharma
Alfa	Prueba de app; puede preceder Semilla
Beta / S1	= paquete Fundadora
S0	Precio base del menú
S2 / Delta	= paquete Anual ; sigue no aprobado
Gamma	Sigue rechazado

Pieza	Relación con CrowdPharma
Café	Misma lección: consumo $\neq$ inversión
Kleo	Misma lección: señal $\rightarrow$ cohorte chica $\rightarrow$ uso

14. Decisiones nuevas

ID	Ítem	Estado
CAP-D11	CrowdPharma = customer-funded B2B; no equity crowdfunding ni crowdfarming de pacientes	DECIDIDO (este documento)
CAP-P10	Revalidar URLs de EXT-005 antes de citar fuera; abogado revisa copy de adopción	PENDIENTE
CAP-P11	Aprobar ejecución comercial de paquetes Semilla/Fundadora (post CAP-P09 y plantillas)	PENDIENTE founder

Ver también

- Resumen diario: [00_QUE_HACER_AHORA.md](#)
- Reglas: [01_REGLAS_Y_CANON.md](#)
- Carriles: [02_CARRILES.md](#)
- S0/S1/S2: [03_ESCENARIOS_S0_S1_S2.md](#)
- Alfa/Beta (experimento): [../metodo_cafe_kleo/PLAN_ALFA_BETA.md](#)
- Evidencia: [evidencia/EXT_CROWDFARMING.md](#)